

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин
директору К.Т. Бекбоев

« 4 » сентябрь 2024-ж.

**ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА**

КАРНИЛЕВ

Соодадагы аталышы
Карнилев

Эл аралык патенттелбеген аталышы
Левокарнитин

Дарынын түрү
Инъекция үчүн эритме

Курамы

Ар бир ампула төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Левокарнитин 1000 мг

Көмөкчү заттар:

Туз кислотасы 10% 0.014 мл

Тазартылган суу q.s. 5 мл.ге чейин

Сүрөттөлүшү

Дээрлик бөлүкчөлөрү жок, түссүздөн саргыч түскө чейин тунук суюктук.

Фармакодарылык тобу

Тамак сиңирүү жолуна жана зат алмашууга таасир тийгизүүчү препараттар. АИЖ ооруларын жана зат алмашууну дарылоо үчүн башка препараттар.

Аминокислоталар жана алардан алынгандар. Левокарнитин.

АТХ коду: A16AA01

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикасы

Фармакологиялык таасири - анаболикалык, гипоксияга каршы, тиреоидге каршы, кайрадан калыбына келтирүүгө түрткү берүүчү, май алмашууга түрткү берүүчү. В тобундагы (Вт — «өсүү витамини») витаминдерге кирет. КоА активдүүлүгүн колдоону камсыздоочу метаболикалык процесстердин кофактору болуп эсептелет. Анаболикалык таасир көрсөтөт, негизги алмашууну төмөндөтөт, белоктук жана углеводдук молекулалардын ажыроосун жайлатат. Ацетил-КоАны пайда кылуу менен (глюконеогенез процессинде

пируваткарбоксилазанын активдүүлүгүн камсыз кылуу, кетондук телолорду пайда кылуу, холиндин синтези жана анын эфирлерин, кычкылдандыруучу фосфорлоонун пайда болуусу жана АТФ пайда болуусу үчүн зарыл) митохондриялардын мембраналар аркылуу өтүшүнө жана узун чынжырчалуу май кислоталарынын (пальмитин жана башкалар) бөлүнүүсүнө көмөк көрсөтөт. Үч лабилдүү металдык топтун болушуна шартталган майды мобилизациялоочу таасир көрсөтөт. Глюкозаны атаандаш сүрүп чыгаруу менен майлуу-кислоталык метаболикалык шунтту кошот, анын активдүүлүгү кычкылтекке чектелген эмес (аэробдук гликолизден айырмаланып), ошондуктан мээнин курч гипоксиясында жана башка критикалык абалдарда натыйжалуу. БНСнын бир аз жабыркоосун пайда кылат, тамак сиңирүүчү зилдин (ашказан жана ичеги) секрециясын жана ферментативдик активдүүлүгүн жогорулатат, тамактын сиңишин жакшыртат. Дененин ашыкча салмагын төмөндөтөт жана булчунда майдын камтылышын азайтат. Физикалык жүктөмгө туруктуулук чегин жогорулатат, жүктөм ацидозунан кийин жок кылууга жана, натыйжада, узак убакытка созулган физикалык жүктөмдөн кийин иш жөндөмдүүлүгүнүн калыбына келишине алып келет. Боордо жана булчуңдарда гликогендин запасын көбөйтөт, аны сарамжалдуу колдонууга көмөк берет. Нейротрофикалык таасир көрсөтөт, апоптоздун өрчүүсүн токтотот, жабыркаган зонаны чектейт жана нерв тканынын түзүмүн калыбына келтирет.

Фармакокинетикасы

Булчуң ичине куюуда плазмада 4 саат ичинде, тамыр ичине аппликациядан 3 саат өткөндөн кийин эле кандан жоголот. Боорго жана миокардга жеңил кирет, булчуңдарга – жайыраак. Бөйрөктөр менен негизинен ацилдик эфирлер түрүндө бөлүнүп чыгат.

Колдонууга көрсөтмө

- чоң адамдарда, балдарда, анын ичинде ымыркайларда жана жаңы төрөлгөндөрдө биринчи жана экинчи левокарнитиндин жетишсиздиги
- гемодиализде узакка турган терминалдык баскычтагы бөйрөктүн оорулары бар бейтаптарда жана төмөнкү абалдар менен коштолгондордо левокарнитиндин экинчи жетишсиздиги:
- диализ учурунда оор жана туруктуу булчуң карышуулары жана/же артериялык гипотензиянын көрүнүштөрү
- энергиянын жетишсиздигине байланыштуу жашоо сапатынын төмөндөшү
- булчуң алсыздыгы жана/же миопатия
- кардиомиопатия.
- туруктуу же эритропозитиндин чоң дозаларын талап кылуучу, уремияда аз кандуулук
- жетишсиз тамак ичүүдөн булчуң массасын жоготуу

Каршы көрсөтмө

- препараттын компоненттерине жогору сезгичтик
- гипернатриемия, гипervолемия.

Колдонуу жолу жана дозалары

Чоң адамдар, балдар, жаңы төрөлгөндөр үчүн: булчуң ичине, тамыр ичине, жайдан (2-3 минута) же инфузия жолу менен куюлат. Адекваттуу дозасын аныктоо үчүн плазмада жана заарада эркин жана ацетилирленген Л-карнитиндин деңгээлин өлчөп, дарылоону көзөмөлдөө керек.

Мээ кан айлануусунун курч бузулууларында суткасына 1 г 3 күн бою, андан кийин суткасына 0,5 г 7 күн бою дайындалат. 10-12 күндөн кийин 3-5 күн ичинде курсту кайталоого болот.

Препаратты курчуу алдындагы жана калыбына келүү мезгилинде, дисциркулятордук энцефалопатияда жана баш мээнин түрдүү жабыркоолорунда, карнитиндин жетишсиздигинде дайындоодо оорулууларга Карнилев препаратынын эритмеси суткасына 0,5-1 г эсебинен тамыр ичине (тамчылатып, жылжытып) же булчуң ичине (күнүнө 2-3 жолу) аралаштырбай 3-7 күн бою куюлат. Зарыл болсо 12-14 күндөн кийин курсу кайталап дайындалат.

Карнитиндин экинчи жетишсиздигинде тамыр ичине жайдан (2-3 мин) гемодиализде - 2 г бир жолу (процедурадан кийин) куюу дайындалат; курч миокард инфарктында, курч жүрөк жетишсиздигинде – суткасына 3-5 г, биринчи 2-3 суткада 2-3 ичүүгө бөлүнгөн кийин дозаны 2 эсеге төмөндөтүү менен; кардиогендик шокто – суткасына 3-5 г, бейтаптын шоктон чыгуусуна чейин 2-3 ичүүгө бөлүнгөн.

Зат алмашуунун тубаса көйгөйлөрүндө: дозасы дарылоо мезгилинде зат алмашуусунда жана айкындуулук деңгээлинде тубаса четтөөлөрүнө көз каранды. Курч декомпенсация учурунда күнүнө 100 мг/кг.га чейин 3-4 ичүүгө дайындалат. Эгерде зарылдык болсо жогору дозаларын колдонууга мүмкүн, бирок бир убакта кыйыр таасирлердин пайда болуу ыктымалдуулугу жогорулайт, мисалы, ич өтүү. Эгерде жакшыруу препараттын инъекциялык формаларын колдонуу менен жетишилсе, анда ичүү үчүн Карнилев эритмесинин күнүнө 1 г дозасы менен колдоочу дарылоону улантууга болот.

Кыйыр таасири

Абдан сейрек:

- окшуу, кусуу, ичтин оорушу, ич өтүү (левокарнитиндин пероралдуу дарылык формасын узакка ичүүдө)
- булчуң алсыздыгы, уремиясы бар оорулууларда карышуулар
- аллергиялык реакциялар (тери бөртмөсү, кычышуу, бөрү жатыш, Квинке шишимиги, анафилактикалык шок)
- дененин өзгөчө жыты
- кумариндер менен (аценокумарол же варфарин) бирге колдонууда ЭНК жогорулоосу.

Дозасын азайтуу көбүнчө препараттан пайда болгон дененин жагымсыз жытын жана бейтаптардагы ашказан-ичеги симптомдорун азайтат же жоготот.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Препаратты ичүүнүн алдында дарыгерге бейтаптын башка препараттарды ичкени тууралуу билдирүү керек.

Глюкокортикоиддер карнитиндин деңгээлин көпчүлүк ткандарда (боордон тышкары) жогорулатат. Холиндин жогору дозалары карнитиндин синтезин жана активдүүлүгүн токтотот. Карнилевду түрдүү анаболикалык каражаттар менен; антиоксиданттар же/жана гипоксияга каршы таасирге ээ препараттар менен айкалыштырууга болот. Липой кислотасы, анаболиктер Карнилев препаратынын таасирин күчөтөт. Кант диабети бар, инсулинди же пероралдуу гипогликемиялык препараттарды алган бейтаптарга Карнилев препаратын дайындоо глюкозанын сиңирүүсү жогорулашынан улам гипогликемияны пайда кылышы мүмкүн, ошондуктан бул категориядагы бейтаптарда препарат менен дарылоо убагында гипогликемиялык препараттардын дозалоо режимин тууралоо үчүн кан плазмасында глюкозанын деңгээлин дайыма көзөмөлдөө керек.

Левкарнитин менен кумарин катарындагы антикоагулянттарды бир убакта алган бейтаптарда Эл аралык нормаланган катыштын (ЭНК) жогорулоосу тууралуу абдан сейрек билдирүүлөр бар.

Карнитинди ичүү кан сары суусунда эркин вальпрой кислотасынын камтылышын жогорулатышы жана аны менен орточо дарылык дозаларын ичүүдө дагы анын таасирин күчөтүшү мүмкүн.

Өзгөчө көрсөтмө

Кант диабети бар, инсулинди же пероралдуу гипогликемиялык препараттарды алган бейтаптарга Карнилев препаратын дайындоо глюкозанын сиңирүүсү жогорулашынан улам гипогликемияны пайда кылышы мүмкүн, ошондуктан бул категориядагы бейтаптарда зарыл болсо, препарат менен дарылоо убагында гипогликемиялык препараттардын дозалоо режимин тууралоо үчүн кан плазмасында глюкозанын деңгээлин дайыма көзөмөлдөө керек. Таржымалында аллергиялык оорлошуусу бар, өнөкөт жүрөк жетишсиздигинде, туздун

кармалуусунан пайда болгон курч бөйрөк алсыздыгында, ошондой эле кортикостероиддик жана кортикотроптук гормоналдык препараттарды кабыл алган бейтаптарда препаратты этияттык менен колдонулат. Препаратты кошумча калийди ичпестен узакка колдонуу гипокалиемияга алып келет. Адекваттуу дозалоону аныктоо үчүн кан плазмасында жана заарада L-карнитиндин эркин жана ацилдик деңгээлин өлчөө менен дарылоону көзөмөлдөө сунушталат. L-карнитин адамдын организмдинде табигый компонент болуп эсептелгендиктен көнүп калууну пайда кылбайт.

Препаратты тамыр ичине куюу жайдан (2-3 мин) болушу керек.

Бөйрөк функциясынын оор бузулуулары бар же терминалдык баскычтагы бөйрөк алсыздыгы бар диализде турган бейтаптарга Карнилевдун жогору дозаларын ичүү сунушталбайт, себеби бул триметиламиндин (ТМА) жана триметил-N-оксиддин (ТМАО) потенциалдуу токсиндүү метаболиттердин топтолуусуна алып келиши мүмкүн, алар адатта заара менен бөлүнүп чыгат (бул зааранын, дем алууда жана тер менен бөлүнүп чыгуулардын “балыктын жыты” менен жыттанышынан билиниши мүмкүн). Бул көрүнүштөр Карнилев препаратынын инъекция үчүн эритмесин тамыр ичине куюуда байкалбайт.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү

Кош бойлуу же бала эмизүү мезгилинде абдан зарыл болгон учурларда гана дайындалат.

Унаа каражатын же потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири

Таасир бербейт.

Ашыкча доза

Симптомдору: препараттын жогору дозалары ич өтүүнү пайда кылат.

Дарылоо: дозасын төмөндөтүү жана колдоочу дарылоо.

Чыгаруу формасы

5 мл инъекция үчүн эритме айнек ампулаларда.

Поливинилхлоридден блистерде 5 ампула.

1 блистер медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге кутуга салынат.

Сактоо шарты

25 °C жогору эмес аба табында, жарык тийбеген жерде сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек!

Сактоо мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбойт!

Дарыканадан берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча

Үчүн өндүрүлдү

SPEY MEDICAL LTD

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,

London, WC1H 9LT, UK (Улуу Британия)

Өндүрүүчү

HELP S.A.

10, Valaoritou str., Metamorphosis,

Attika, 14452, Greece (Греция)

**Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюн
керектөөчүлөрдөн арыз-доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:**

«Аман Фарм» ЖЧК Бишкек ш.,

Кыргыз Республикасы, Шооруков көчөсү 36

E-mail: aman.pharm12@gmail.com